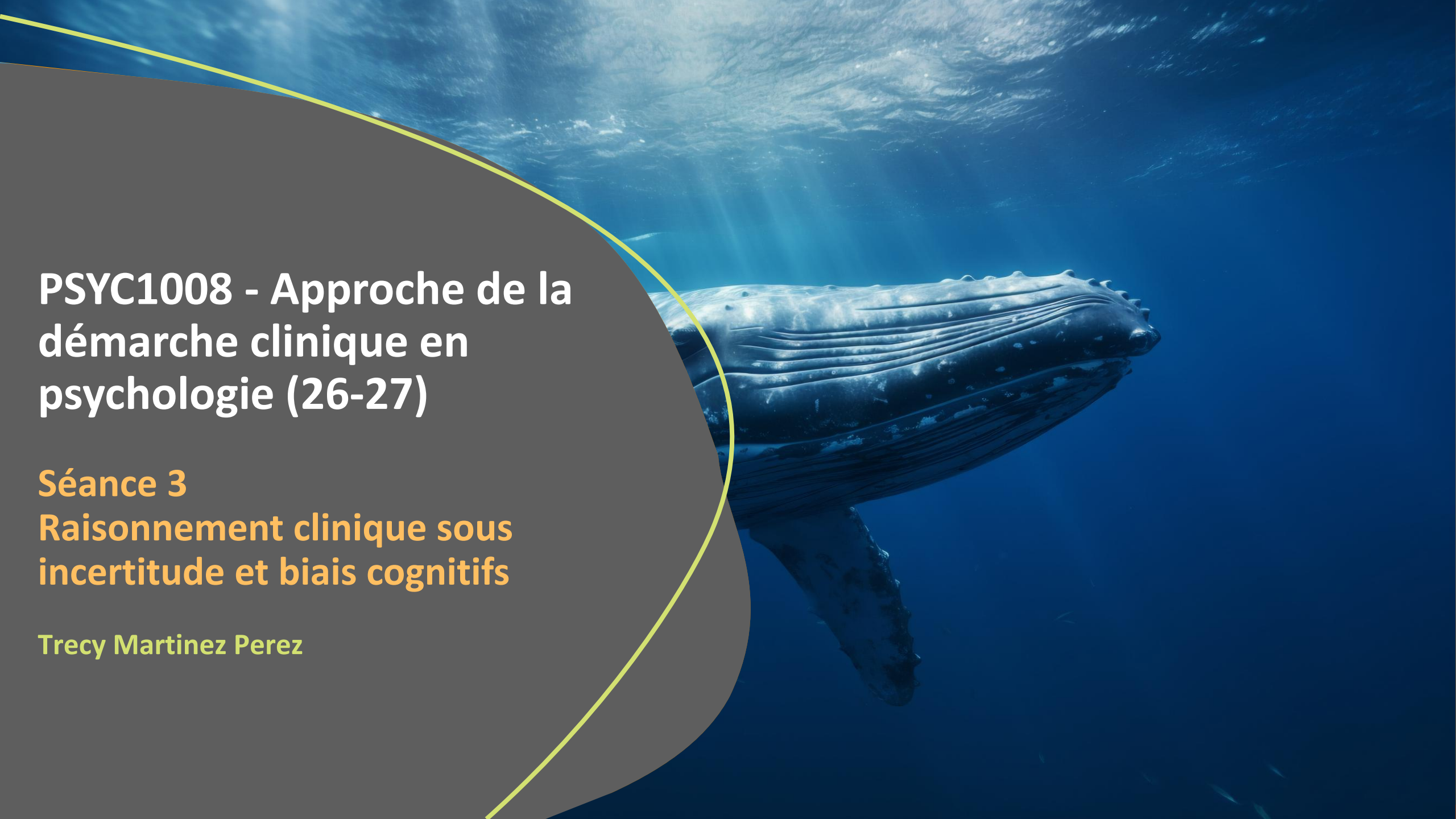


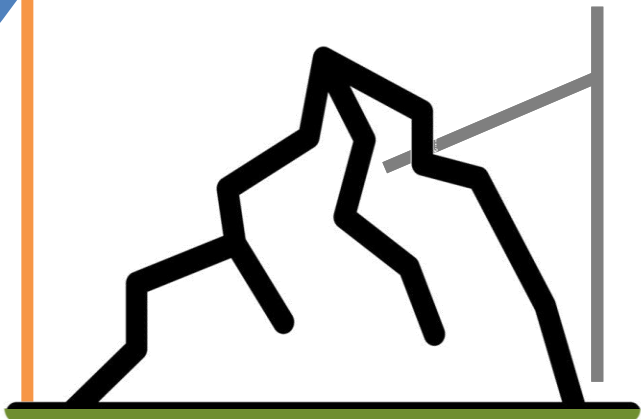


# PSYC1008 - Approche de la démarche clinique en psychologie (26-27)

## Séance 3 Raisonnement clinique sous incertitude et biais cognitifs

Trecy Martinez Perez

## Approche Centrée sur la Personne (ACP)



Ce que le psychologue (l'étudiant) fait

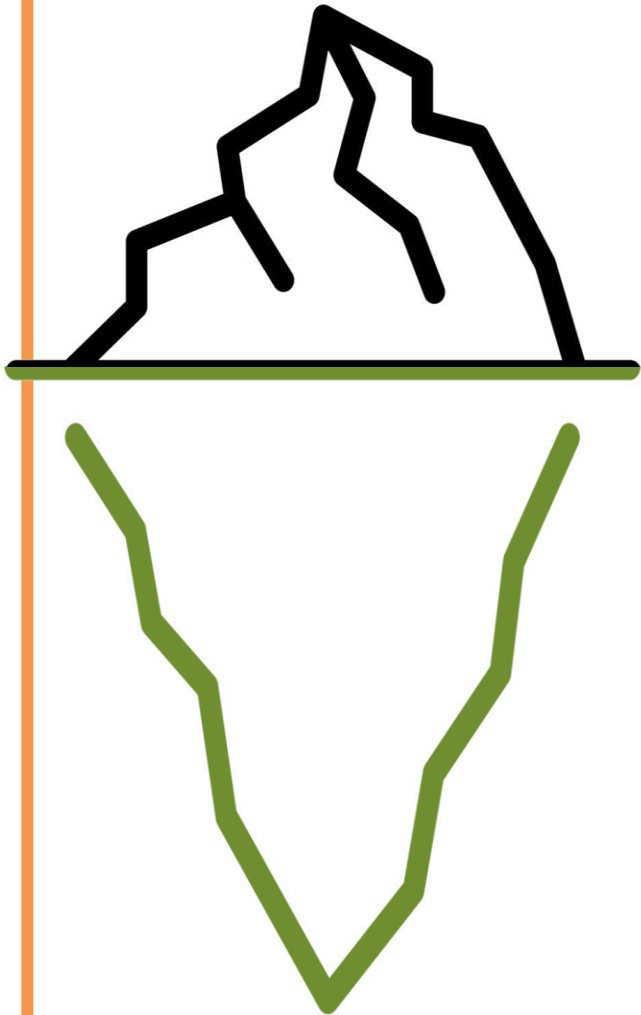


Quels processus de pensée et de prise de décision (= **raisonnement clinique**) amènent le psychologue (l'étudiant) à agir ainsi ?

Quelles informations alimentent le **raisonnement clinique** du psychologue (de l'étudiant) ?



## Approche Centrée sur la Personne (ACP)



Authenticité dans la relation

Considération positive inconditionnelle

Empathie

Renforcer les compétences d'autodétermination de la personne > consentement éclairé, partenaire dans les décisions, liberté de choix, ...

Identifier et valoriser les ressources, capacités, forces, le potentiel

S'intéresser aux valeurs de la personne et aligner les décisions sur ces valeurs

Avoir une vision positive, non normative et large du concept de vie accomplie

...

# Démarche clinique en psychologie

## Approche Centrée sur la Personne (ACP)

4

3

Ce que le psychologue (l'étudiant) fait

Quels processus de pensée et de prise de décision (= **raisonnement clinique**) amènent le psychologue (l'étudiant) à agir ainsi ?

Quelles informations alimentent le **raisonnement clinique** du psychologue (de l'étudiant) ?





# Aujourd'hui

Partie **visible** - Les temps forts de la démarche clinique

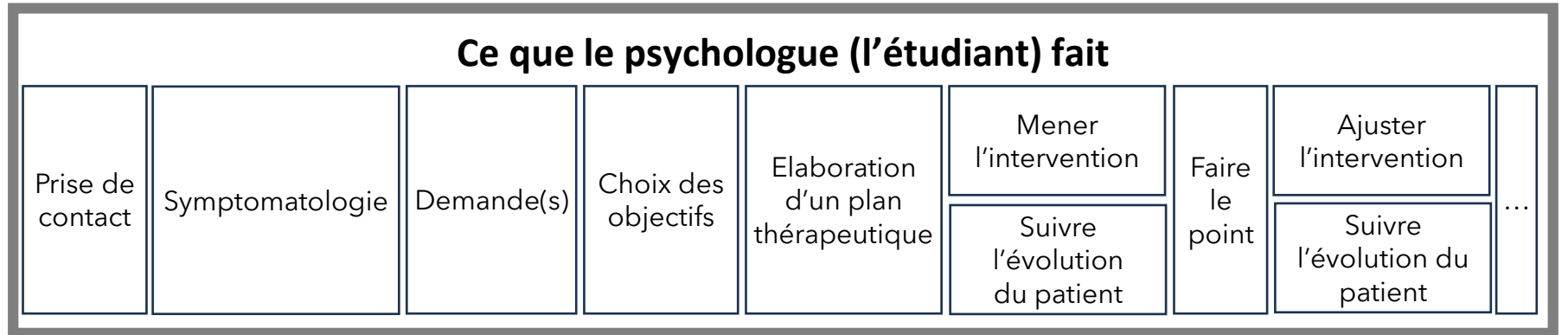
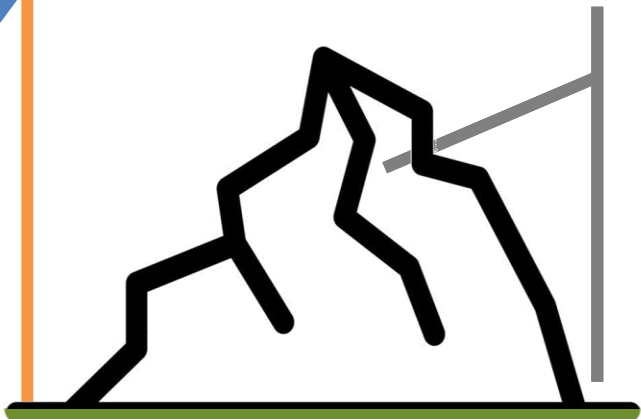
Partie **immergée** - Le raisonnement clinique

Partie **immergée** - Les informations qui alimentent le RC

Prochain rendez-vous

# Démarche clinique en psychologie

## Approche Centrée sur la Personne (ACP)

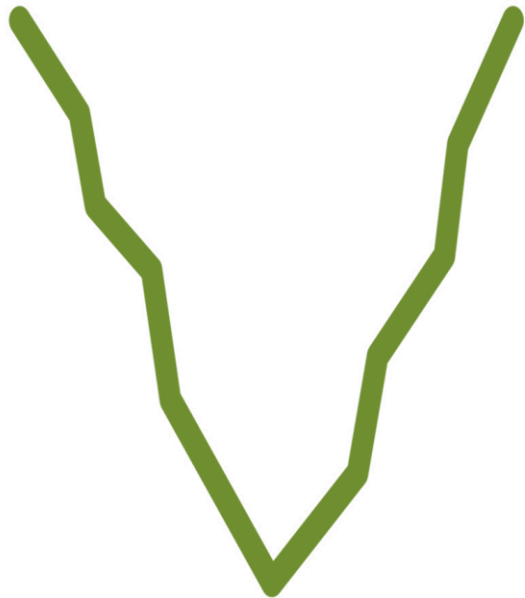


### ! Flexibilité et ajustement de la démarche !

(1) Tous les temps forts ne sont **pas systématiquement présents**. Des exemples ?

### ! Flexibilité et ajustement de la démarche !

(2) Les **moyens varient**. Quand utiliser l'entretien clinique, l'observation (globale vs. systématique), l'évaluation outillée ?



# Zoom sur les 1ers temps forts

## Définition

**L'examen psychologique constitue une étape dans la relation d'aide.**

La spécificité de l'examen psychologique réside dans l'offre d'un moment et d'un espace **entièrement consacrés** à la personne, dans la perspective clairement formulée d'essayer d'éclaircir, avec **son aide et sa participation effective**, les éléments participant aux difficultés qu'elle rencontre.

C'est une situation limitée dans le temps, ni trop courte, ni trop longue, qui permet au clinicien une observation de la personne et de son fonctionnement psychologique, appuyée sur un matériel concret stimulant, utilisé au sein d'une dynamique relationnelle.

# Zoom sur les 1ers temps forts

## Objectifs

L'examen psychologique d'une personne a pour but de fournir une **compréhension intégrée et contextualisée** des problèmes qui ont motivé la demande d'aide (Grégoire, 2014) :

- afin de répondre à une demande d'aide ou de conseils formulée par le patient et/ou son entourage ;
- de déterminer quelles sont les actions les plus appropriées ;
- d'améliorer la qualité de vie et le rétablissement de la personne.

**=> La pertinence de l'examen n'est pas intrinsèque, mais extrinsèque !**

# Zoom sur les 1ers temps forts

## Objectifs

### APA (art. 9.01)

Les psychologues **fondent les opinions** contenues dans leurs recommandations, rapports et déclarations de diagnostic ou d'évaluation, y compris des témoignages médico-légaux, sur **des informations et des techniques suffisantes pour étayer** leurs résultats.

Les psychologues ne fournissent un avis sur les caractéristiques psychologiques d'un individu qu'après avoir effectué un **examen adéquat** pour étayer leurs déclarations ou leurs conclusions.



# Aujourd'hui

Partie **visible** - Les temps forts de la démarche clinique

**Partie immergée - Le raisonnement clinique**

Partie **immergée** - Les informations qui alimentent le RC

Prochains rendez-vous

# Raisonnement clinique (RC)

[...] the thinking and **decision-making** processes associated with clinical practice [...] ; [...] to take the **best judged** action in a specific context [...]  
(Higgs et al., 2000)

The cognitive process by which clinicians **integrate** clinical information, preferences, medical knowledge, and contextual factors to **make decisions about the care** of an individual patient (Cook, 2019)

Processus cognitif

Intégration d'informations

Prise de décision

Meilleurs soins

# Raisonnement clinique (RC)

Littérature scientifique surtout sur le RC dans le contexte de **l'évaluation** et chez les **médecins**

Lors des examens psychologiques, plusieurs pensées et prises de décision dont

- La génération et la mise à jour d'hypothèses
- Le choix de questions d'entretien appropriées
- Le choix d'outils d'évaluation et de seuils de comparaison avec l'échantillon normatif
- La mise en évidence de plusieurs options thérapeutiques

# Raisonnement clinique (RC)

## Spécificités du RC dans nos disciplines peu connues (Young et al., 2020)

**Table 2** Representation of Health Professions and Level of Learner

| Health Professions        | n   | % of 625 |
|---------------------------|-----|----------|
| Medicine                  | 335 | 53.6     |
| Nursing                   | 192 | 30.7     |
| Dentistry                 | 26  | 4.2      |
| Physical Therapy          | 18  | 2.9      |
| Occupational Therapy      | 16  | 2.6      |
| Midwifery                 | 6   | 1.0      |
| Pharmacy                  | 6   | 1.0      |
| Paramedic                 | 3   | 0.5      |
| Dental Hygiene            | 2   | 0.3      |
| Veterinary Medicine       | 2   | 0.3      |
| Speech Language Pathology | 1   | 0.2      |
| Clinical Psychology       | 1   | 0.2      |
| Diagnostic Imaging        | 1   | 0.2      |

# Coexistence de 2 processus de pensée

## (Dual process theory of cognition)

### ① Raisonnement non analytique

- Analyse rapide des informations directement accessibles
- Plus « intuitif »
- Immédiat et rapide - peu coûteux

### ② Raisonnement analytique

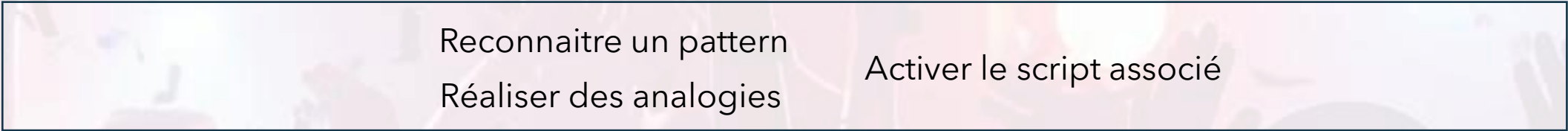
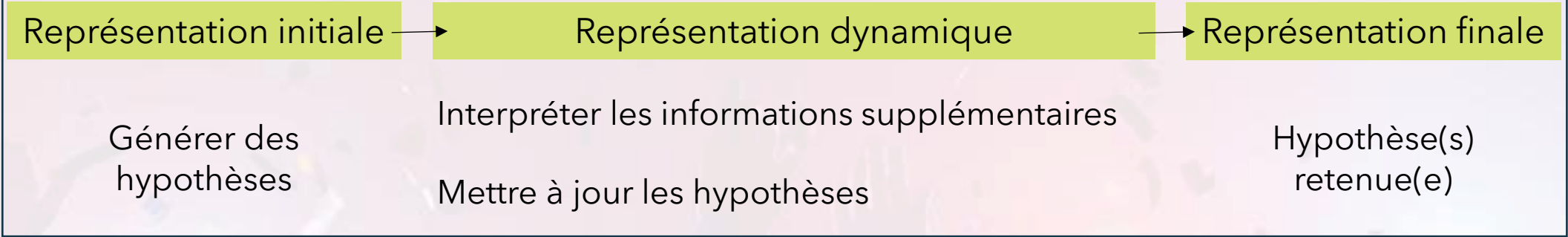
- Conscient
- Plus « réfléchi »
- Plus lent et coûteux

# Coexistence de 2 processus de pensée

## (Dual process theory of cognition)



Cognitions



Microdécisions

Quelles informations supplémentaires recueillir et comment (quelle question, quel outil, ...) ?

Macro

En fonction de la donnée, quel diagnostic ? quel éventail d'actions proposer ?

Pas de modèle consensuel

Schéma créé sur la base des travaux et écrits de Higgs et al. (2019), Charlin et al. (2007; 2012), Ginsberg et al. (2016); Peleccia et al. (2011), Yazdani et al. (2019); Wilcox et al. (2015; 2023).



Contribution pour réguler et apprendre de son expérience

The background is a solid yellow color. It features two large, white speech bubbles. The top bubble contains the text 'POUR ?' and the bottom bubble contains 'CONTRE ?'. There are also four faint, white icons of mobile phones scattered around the speech bubbles: one in the top-left corner, one in the top-right corner, one in the bottom-left corner, and one in the bottom-right corner.

**POUR ?**

**CONTRE ?**

La génération d'hypothèses  
dès le 1<sup>er</sup> contact

# RC analytique

Comporte une série d'étapes

Long et fastidieux les premières fois

De plus en plus aisé avec l'expérience

Nécessaire même chez l'expert

# RC non analytique

« intuition clinique »

Formuler très rapidement et sans effort conscient une ou plusieurs hypothèses de travail en prenant en compte un nombre limité d'informations immédiatement accessibles dans l'environnement

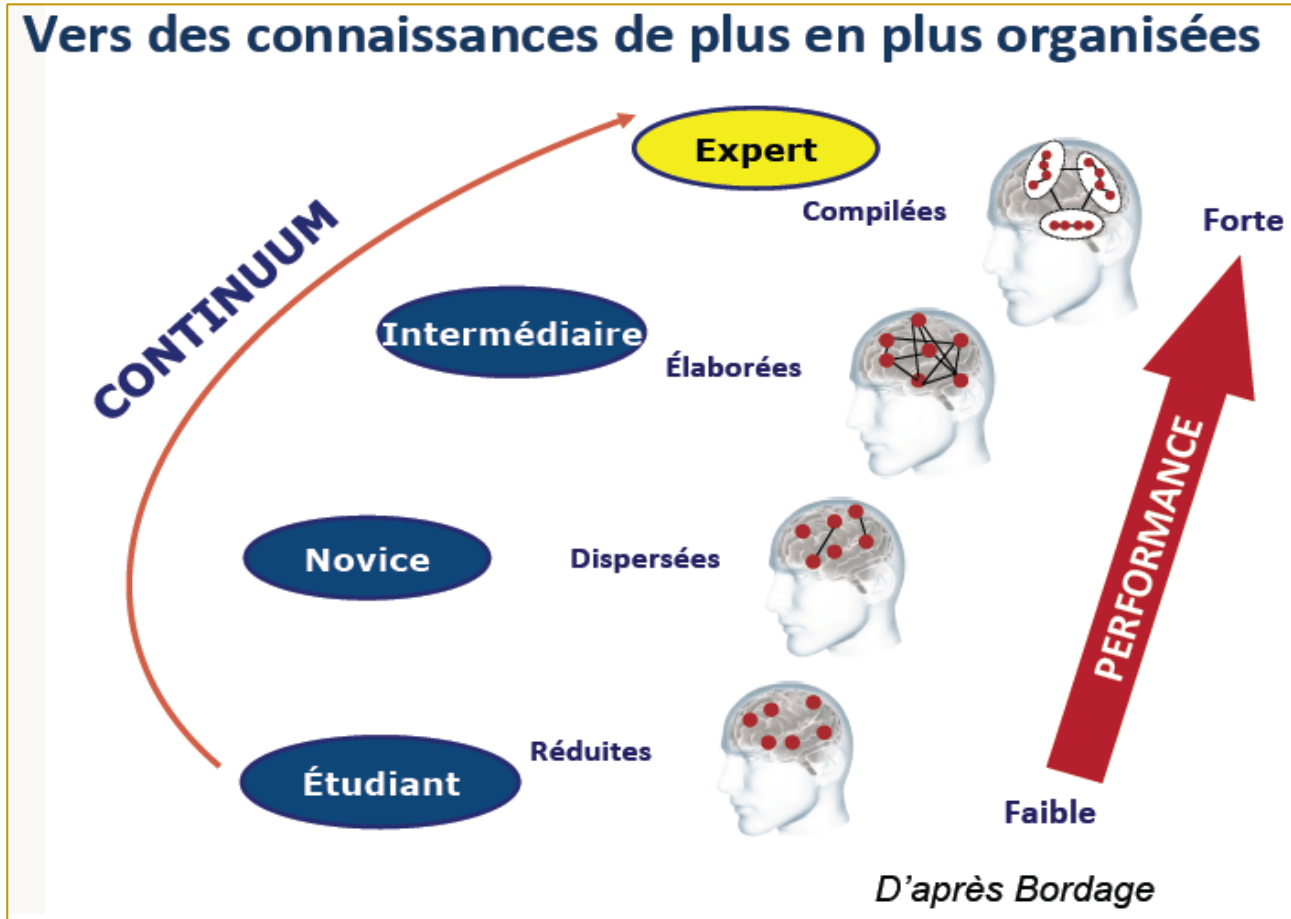
**MAIS importance de vérifier de manière analytique cette « intuition »**

Se construit par

- La mobilisation des **processus** du raisonnement analytique
- La mobilisation des **connaissances** organisées pour raisonner = SCRIPTS

# RC non analytique

**Scripts cliniques** = Réseau personnalisé de connaissances, mobilisables pour l'action, qui reflète l'intégration par le clinicien de données scientifiques, de savoirs cliniques et d'expériences acquises de cas antérieurs



# RC non analytique

## Les scripts cliniques permettent de...

Avoir rapidement des hypothèses de travail

Identifier plus rapidement les actions « payantes » pour confirmer ou infirmer ces hypothèses de travail

Reconnaître plus facilement les profils plus complexes - atypiques

À retenir : L'importance d'évaluer les résultats du processus de raisonnement analytique (est-ce que mon raisonnement était adéquat ou pas ?) et d'organiser les connaissances pour permettre la construction de nouveaux scripts ou l'ajustement des scripts existants > **article de Willems et al. (2021) sur eCampus**



# Aujourd'hui

Partie **visible** - Les temps forts de la démarche clinique

Partie **immergée** - Le raisonnement clinique

- **Biais cognitifs**

Partie **immergée** - Les informations qui alimentent le RC

Prochains rendez-vous

**Une baleine bleue mesure-t-elle plus de 49m ?**



**Combien mesure une baleine bleue ?**



# Coexistence de 2 processus de pensée

## (Dual process theory of cognition)

### ① Raisonnement non analytique

- Analyse rapide des informations directement accessibles
- Plus « intuitif »
- Immédiat et rapide - peu coûteux

} **Heuristiques**  
Raccourcis de pensée

### ② Raisonnement analytique

- Conscient
- Plus « réfléchi »
- Plus lent et coûteux



**Biais cognitifs**

Erreurs « communes » d'interprétation

# Justice & biais cognitifs (Berthet, 2022)

**Biais d'ancrage**

**Biais de rétrospection**

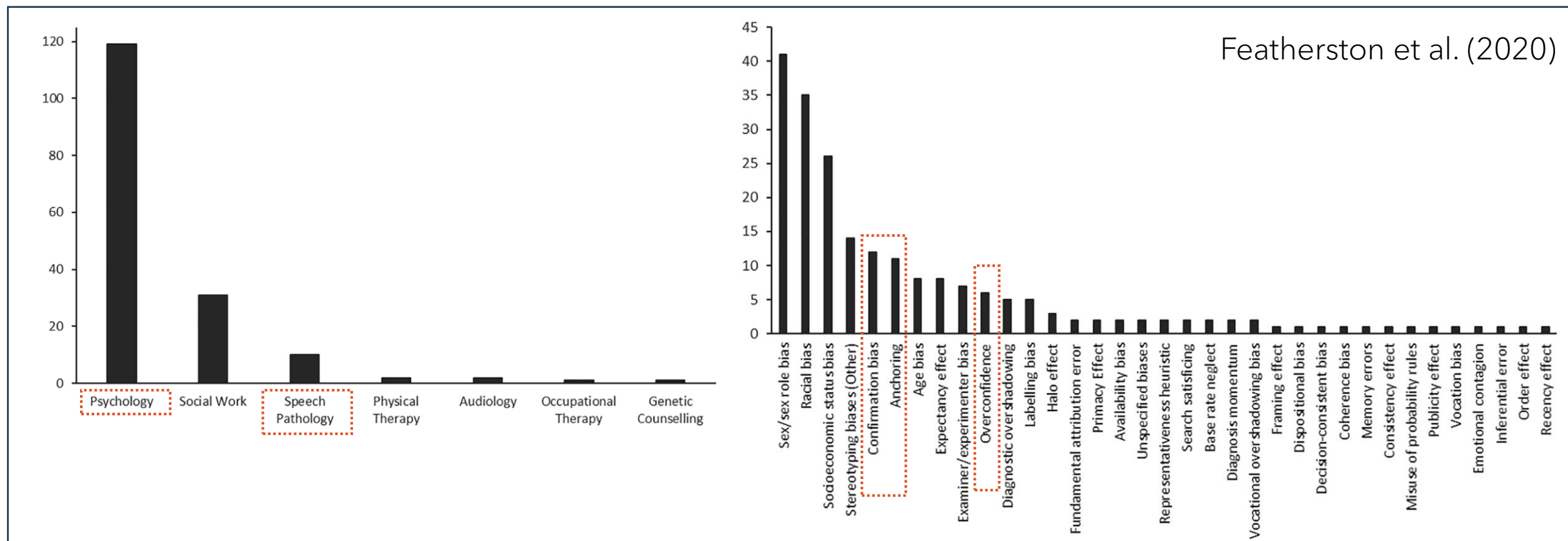
**Influence d'autres facteurs**



# Quels biais cognitifs connaissez-vous ?

# Quels biais cognitifs connaissez-vous ?

## Biais cognitifs dans nos disciplines



# Biais d'ancrage

Pas uniquement pour des nombres

1<sup>re</sup> impression

Tendance à trop s'appuyer sur la première information reçue (= ancre) pour guider notre réflexion et nos actions

La façon dont le patient répond à la première Q<sup>o</sup> ouverte du clinicien

Peut se combiner avec l'effet de halo

# Effet de halo

## Tirer des conclusions générales sur base d'une caractéristique spécifique

- Label bio > sous-estimation de la teneur calorique de l'aliment
- Une femme maquillée > bonne santé
- Un « beau » patient > plus intelligent, sportif, meilleure santé mentale, meilleure adhérence au traitement

**Effet de halo *inversé*** : caractéristique négative (p.e. patient qui sent mauvais) > impression générale négative... or pourrait s'expliquer par des difficultés de type frontale

# Biais de disponibilité

Tendance à trop s'appuyer sur la première information qui nous vient en tête

« Si elle vient en tête rapidement et facilement, c'est que c'est la bonne »

Quid de la fréquence de cette information ?

Quid du caractère émotionnel/affectif associé à cette information ?

Rmq : terme « information » à considérer au sens large : diagnostic, stratégie thérapeutique, ...

# Biais de confirmation

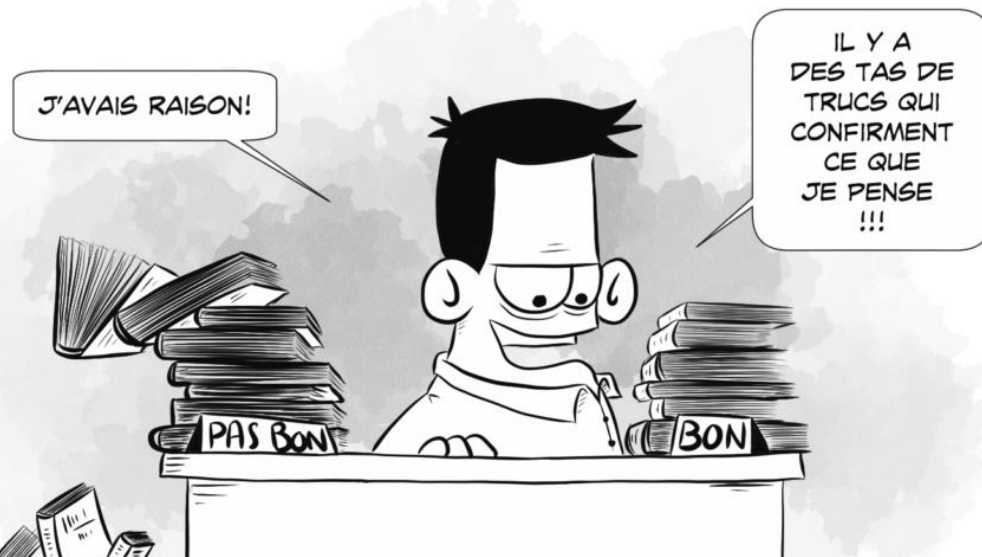
Privilégier les informations qui vont dans notre sens

Négliger les informations qui vont dans le sens contraire

Peut contribuer au biais d'excès de confiance



## LES BIAIS COGNITIFS: LE BIAIS DE CONFIRMATION



# Biais de pensée de groupe

Contexte fréquent : présentation de cas et intervision

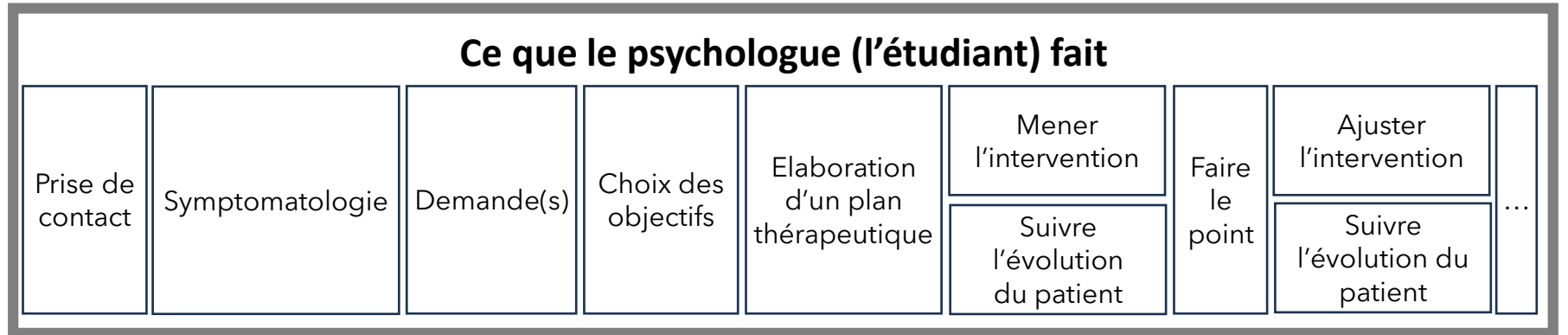
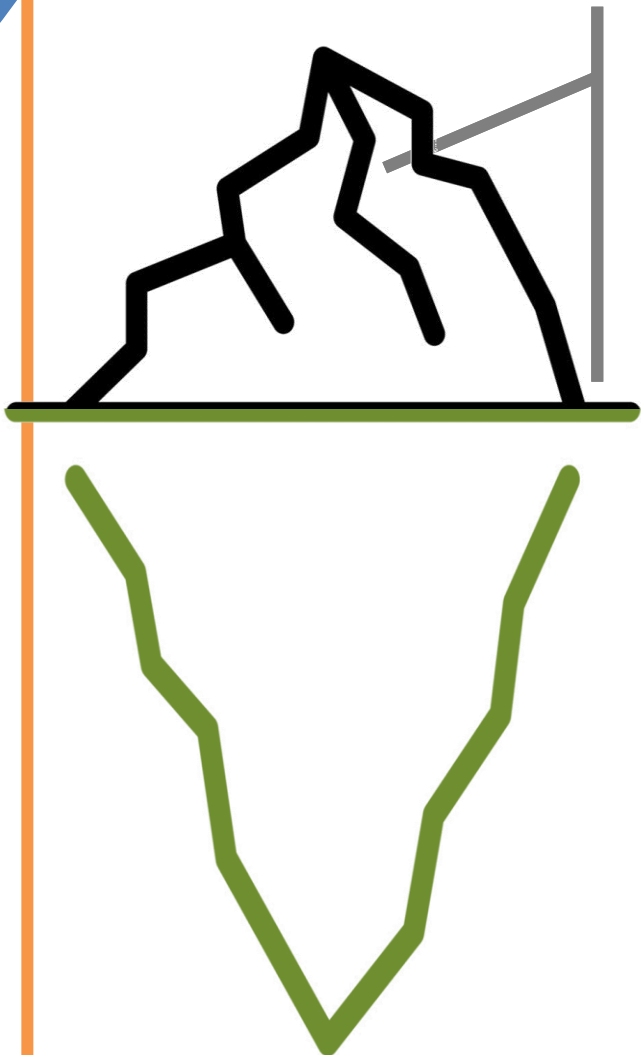
Converger **vers une décision commune**

Tendance à faire coïncider son avis personnel avec ce qu'on considère être l'opinion consensuelle du groupe

Tendance à mettre la pensée critique à l'écart



## Approche Centrée sur la Personne (ACP)



### Où agiraient en priorité les biais suivants ?

Biais d'ancrage  
Effet de Halo  
Biais de disponibilité  
Biais de confirmation  
Biais d'excès de confiance  
Biais d'autorité

# Une liste non exhaustive...

## **Why Ineffective Psychotherapies Appear to Work: A Taxonomy of Causes of Spurious Therapeutic Effectiveness**

**Scott O. Lilienfeld<sup>1</sup>, Lorie A. Ritschel<sup>2,3</sup>, Steven Jay Lynn<sup>4</sup>,  
Robin L. Cautin<sup>5</sup>, and Robert D. Latzman<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Department of Psychology, Emory University; <sup>2</sup>Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill; <sup>3</sup>3C Institute, Cary, NC; <sup>4</sup>Department of Psychology, Binghamton University; <sup>5</sup>Department of Psychology, Manhattanville College; and

<sup>6</sup>Department of Psychology, Georgia State University

# Une liste non exhaustive...

**Table 1.** Causes of Spurious Therapeutic Effectiveness and Research Safeguards Against Them

| CSTE                                                                          | Description                                                                                                                 | Research safeguards                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Category 1 CSTE: Erroneous perceptions of client change in its absence</b> |                                                                                                                             | All Category 1 CSTE: Well-validated outcome indicators |
| 1. Illusory placebo effects                                                   | Perceived improvement occurring in the absence of genuine improvement                                                       | (none additional)                                      |
| 2. Palliative benefits                                                        | Feeling better about one's signs and symptoms without tangible improvements in them                                         | (none additional)                                      |
| 3. Confusing insight with improvement                                         | Mistaking apparent understanding of one's problem with improvement in that problem                                          | (none additional)                                      |
| 4. Retrospective rewriting of pre treatment functioning                       | Belief that one has improved arising from a tendency to remember one's pretreatment functioning as worse than it was        | Measures of pretreatment functioning                   |
| 5. Response-shift bias                                                        | Change in one's evaluation standard with respect to an outcome dimension as a consequence of treatment                      | Measures of pretreatment functioning                   |
| 6. Reduction in cognitive biases                                              | Declines in cognitive biases tied to pretreatment reporting of symptoms                                                     | Measures of cognitive biases throughout treatment      |
| 7. Demand characteristics                                                     | Tendency of clients to report improvement in accord with what they believe to be the therapist's or researcher's hypotheses | Outcome measures low in reactivity                     |

# Une liste non exhaustive...

## Category 2 CSTEs:

### Misinterpretations of actual client change stemming from extratherapeutic factors

All Category 2 CSTEs: Randomization to treatment conditions

|                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Spontaneous remission                     | Tendency of some psychological conditions to improve on their own                                            | (none additional)                                                                                                                                  |
| 17. History                                   | Widely shared events transpiring outside of treatment                                                        | Repeated measurements throughout treatment. Tracking of life events outside of treatment                                                           |
| 18. Cyclical nature of some disorders         | Tendency of some psychological conditions to go up and down                                                  | Long-term follow-ups                                                                                                                               |
| 19. Self-limiting nature of disorder episodes | Tendency of individuals with psychological conditions to improve once episodes have run their natural course | Long-term follow-ups                                                                                                                               |
| 20. Regression to the mean                    | Tendency of extreme scores to become less extreme on retesting                                               | Use of pre- and posttest measures with high reliability. Minimizing use of extreme group designs. Estimating and controlling for measurement error |
| 21. Maturation                                | Improvement arising from naturally occurring psychological growth                                            | (none additional)                                                                                                                                  |
| 22. Multiple treatment interference           | Tendency of individuals who obtain one treatment to obtain others at the same time                           | Use of adjunctive treatments as covariates in analyses                                                                                             |

# Une liste non exhaustive...

## Category 3 CSTEs:

**Misinterpretations of actual client change stemming from nonspecific treatment factors**

- |                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Placebo effects      | Improvement stemming from the expectation of improvement                                                                                         |
| 25. Novelty effects      | Improvement owing to enthusiasm regarding the prospects of receiving a new intervention                                                          |
| 26. Effort justification | Clients who invest substantial time, energy, effort, and resources in an intervention often feel a psychological need to justify this commitment |

All Category 3 CSTEs: Common factor control groups

Inclusion of measures of proposed mediators. Measurement of expectancies  
 Inclusion of measures of proposed mediators. Measurement of expectancies  
 Inclusion of measures of proposed mediators

# Comment réduire l'influence de ses biais cognitifs lors de l'examen psychologique ?

- ① En prendre conscience



Cognitive Bias and Blindness:  
A Global Survey of Forensic Science Examiners

Jeff Kukucka\*  
Towson University, United States

Saul M. Kassin and Patricia A. Zapf  
John Jay College of Criminal Justice, United States

Itiel E. Dror  
University College London (UCL), United Kingdom

**Table 1**  
*Beliefs (%) about the Scope of Bias*

|                                                                                                            | Yes   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| In your opinion, is cognitive bias a cause for concern in the forensic sciences <i>as a whole</i> ?        | 70.97 |
| In your opinion, is cognitive bias a cause for concern in <i>your specific domain</i> of forensic science? | 52.36 |
| In your opinion, are <i>your own judgments</i> influenced by cognitive bias?                               | 25.69 |



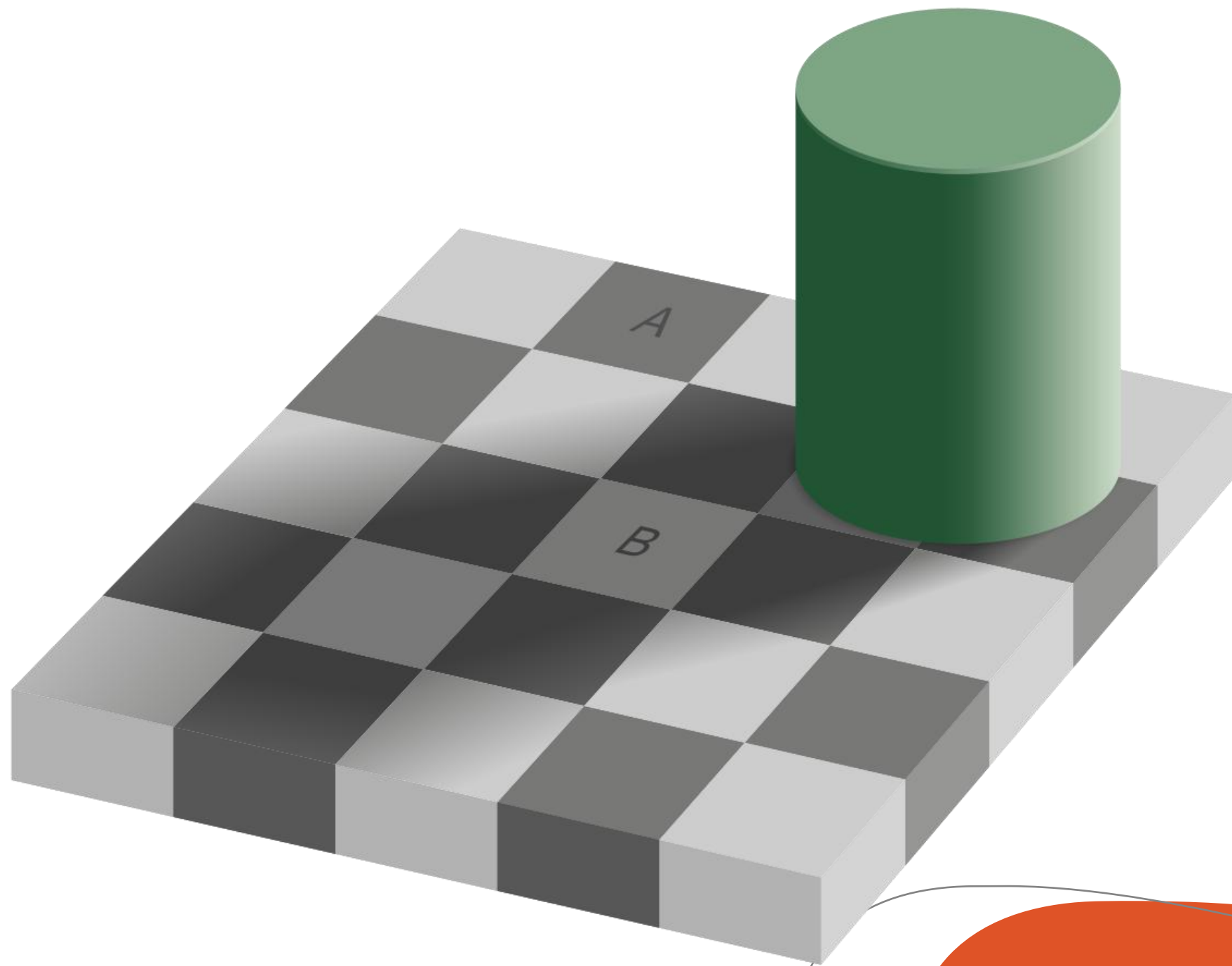
## Le biais de l'angle mort

C'est la tendance à se considérer soi-même moins biaisé que les autres...

Ridicule ! Tous ces gens  
qui paniquent à cause  
des médias et qui se  
ruent sur les stocks  
sans réfléchir...



Moi c'est pas  
pareil, je suis juste  
prévoyant.



# Comment réduire l'influence de ses biais cognitifs lors de l'examen psychologique ?

① **En prendre conscience** mais ce n'est pas suffisant !

# Recommandations de Lilienfeld et al. (2012) pour limiter les biais cognitifs

Rechercher des preuves qui infirment notre intuition

Ne pas trop s'attacher à nos seules hypothèses

Considérer des hypothèses rivales

Mettre nos intuitions à des tests systématiques

Être conscient de nos angles morts

Encourager la dissidence/la contestation

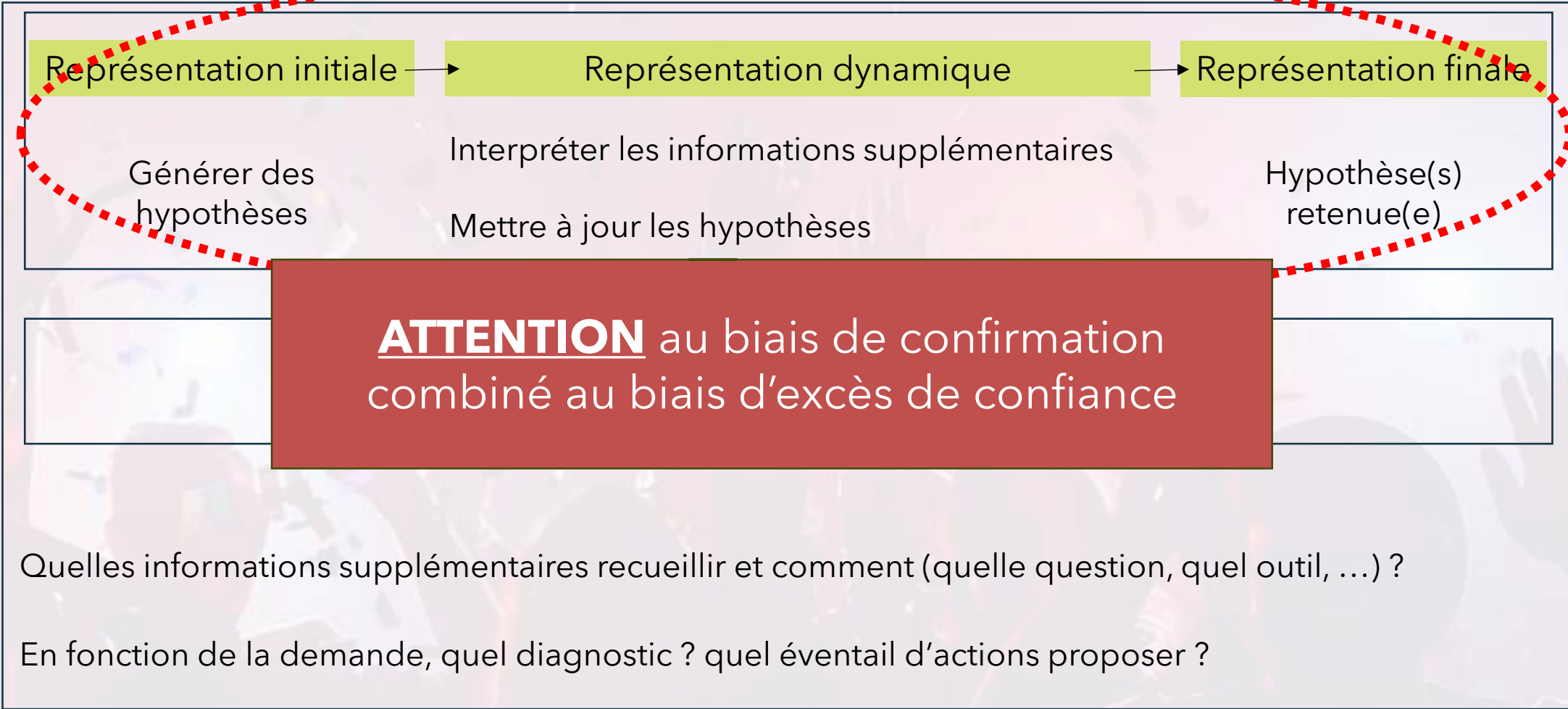
Quantifier, quantifier, quantifier

Maintenir une attitude autocritique

# Comment réduire l'influence de ses biais cognitifs lors de l'examen psychologique ?

- ① **En prendre conscience** mais ce n'est pas suffisant !
- ② Solliciter le « système 2 » - **raisonnement analytique**

**Cognitions**



**Connaissances**

**Expériences antérieures**

**Contexte**

**Métacognition pour réguler et apprendre de son expérience**

# Comment réduire l'influence de ses biais cognitifs lors de l'examen psychologique ?

- ① **En prendre conscience** mais ce n'est pas suffisant !
- ② Solliciter le « système 2 » - **raisonnement analytique** MAIS
- ③ ... avec **méthode**/procédure (guidelines, checklists ; *infirmer* et pas confirmer ; « se forcer » à expliciter *min. 3* hypothèses crédibles dès les premières étapes ; réaliser des prédictions sur les hypothèses de manière *prospective* ...)

# Comment réduire l'influence de ses biais cognitifs lors de l'examen psychologique ?

- ① **En prendre conscience** mais ce n'est pas suffisant !
- ② Solliciter le « système 2 » - **raisonnement analytique** MAIS
- ③ ... avec **méthode**/procédure (guidelines, checklists ; *infirmer* et pas confirmer ; « se forcer » à expliciter *min. 3* hypothèses crédibles dès les premières étapes ; réaliser des prédictions sur les hypothèses de manière *prospective*)
- ④ ... avec des **contestataires** (dans un climat de confiance, avec des collègues aux profils variés, demande explicite de mise en question; ...)

# Comment réduire l'influence de ses biais cognitifs lors de l'intervention ?

>> Cours en Master



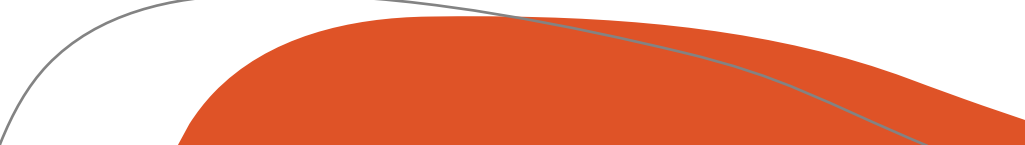
# Raison sous influence

## Les biais dans le plat

**Penser "vraiment", c'est penser contre soi » (O. Houdé)**

Le doute est une force. Une vraie belle force.

Veille simplement qu'elle te pousse toujours en avant. (P. Bottero)





# Aujourd'hui

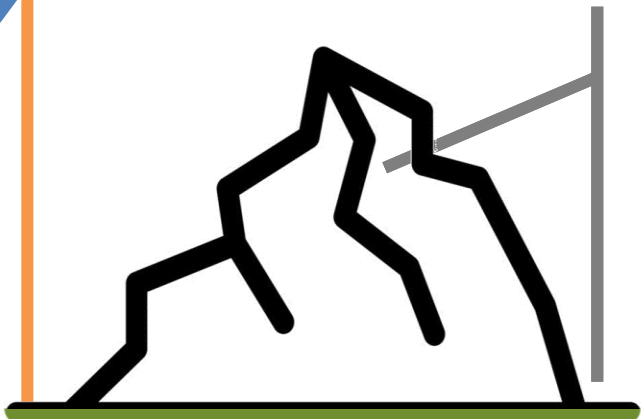
Partie **visible** - Les temps forts de la démarche clinique

Partie **immergée** - Le raisonnement clinique

**Partie immergée** - Les informations qui alimentent  
le RC

Prochains rendez-vous

## Approche Centrée sur la Personne (ACP)



Ce que le psychologue (l'étudiant) fait



Quels processus de pensée et de prise de décision (= **raisonnement clinique**) amènent le psychologue (l'étudiant) à agir ainsi ?

Quelles informations alimentent le **raisonnement clinique** du psychologue (de l'étudiant) ?



# Exercice - Minh Liu (consignes)

(A) Repérez les éléments se rapportant aux 4 piliers de l'EBP

| Pilier de l'EBP                                     | Éléments repérés |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Données de la recherche scientifique                |                  |
| Ressources / expertise clinique du psychologue      |                  |
| Caractéristiques, besoins et préférences du patient |                  |
| Contexte                                            |                  |

(B) Afin de réduire l'influence des biais cognitifs, que manque-t-il dans le RC du psychologue ?

# Exercice - Minh Liu (vignette)

M. Liu, 43 ans, contacte spontanément par téléphone le centre CUPA, un centre de première ligne en santé mentale où interviennent des psychologues conventionnés. Il décrit une perte progressive de motivation, un isolement social, un sommeil perturbé et une inquiétude quasi constante. M. Liu évoque ses dernières vacances comme un « déclencheur » d'un sentiment de vide. Il confie avoir déjà eu le souhait de consulter un psychologue par le passé pour un état similaire, mais il n'avait pas entrepris les démarches. Il exprime une peur de « retomber au plus bas ». Il souhaite comprendre ce qui lui arrive et éviter une rechute.

Suite à cette conversation téléphonique, le psychologue prépare les futures rencontres. Il envisage un entretien clinique approfondi sur une première séance afin de mieux comprendre la symptomatologie. Il envisage ensuite de recourir à un questionnaire validé à large spectre pour explorer plusieurs catégories de symptômes dont ceux relatifs à la dépression et à l'anxiété qui correspondent à ses premières hypothèses de travail. Les informations recueillies permettront de choisir, en concertation avec le patient, un suivi approprié.

# Exercice – Mr Bellevue (consignes)

- (A) Sur base de la vignette et du tableau vert, identifiez dans quel contexte de travail Mr Bellevue rencontre la psychologue. Cela vous sera utile pour la question (B)
- (B) Repérez les éléments se rapportant aux 4 piliers de l'EBP

| Pilier de l'EBP                                     | Éléments repérés |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Données de la recherche scientifique                |                  |
| Ressources / expertise clinique du psychologue      |                  |
| Caractéristiques, besoins et préférences du patient |                  |
| Contexte                                            |                  |

# Exercice – Mr Bellevue (vignette)

Monsieur Bellevue, 35 ans, consulte pour des difficultés multiples qui le submergent. Il exprime le souhait de « faire le tri », d'y voir plus clair et de comprendre ce qui est essentiel pour lui. Il décrit des difficultés à s'endormir et une inquiétude persistante concernant la santé de son meilleur ami, atteint d'une maladie grave. Il rapporte également des craintes concernant sa propre santé, en particulier en lien avec un diagnostic récent du syndrome d'Usher, une maladie génétique affectant l'audition. Sur le plan professionnel, il se décrit comme perfectionniste, exigeant envers lui-même, et mentionne une surcharge de travail accrue ces derniers mois.

Lors des premières séances d'entretien, la psychologue prévoit d'explorer les difficultés évoquées par Monsieur Bellevue ainsi que ses besoins et sa demande. L'entretien visera également à comprendre la perception du patient de son diagnostic et à identifier ses ressources personnelles et sociales. La psychologue envisage des méthodes d'évaluation validées pour mieux cerner les difficultés de Monsieur Bellevue et une prise en charge construite en cohérence avec les recommandations de bonne pratique clinique.

# Exercice – Mr Bellevue (vignette)

| Contexte clinique                                                               | Implications                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consultation dans un service hospitalier, après une annonce diagnostique</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraintes institutionnelles (temps limité, consultations brèves, mandat de soutien)</li> <li>• Nécessité de collaborer avec le corps médical</li> <li>• Importance des protocoles interdisciplinaires et du cadre éthique hospitalier</li> </ul>                        |
| <b>Cabinet privé en pratique indépendante</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomie de la clinicienne dans le choix des outils et de l'approche</li> <li>• Question de l'accessibilité financière des soins pour le patient (pas de remboursement structurel, honoraires libres)</li> <li>• Absence d'équipe pluridisciplinaire formelle</li> </ul> |
| <b>Service de santé mentale agréé</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délai d'attente, financement partiel, travail en équipe, partage d'informations encadré</li> <li>• Cadre légal du secret professionnel partagé</li> <li>• Mandat de prévention et d'intervention à moyen terme</li> </ul>                                                 |
| <b>Cellule bien-être d'une entreprise / service RH</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandat organisationnel (prévention du burnout, adaptation du poste)</li> <li>• Limites de la confidentialité dans un cadre professionnel</li> <li>• Objectifs partagés entre santé individuelle et performance</li> </ul>                                                 |



# Aujourd'hui

Partie **visible** - Les temps forts de la démarche clinique

Partie **immergée** - Le raisonnement clinique

Partie **immergée** - Les informations qui alimentent le RC

**Prochains rendez-vous**

# Prochains cours

**24 septembre :** eCampus - Analyser un entretien clinique avec un patient

**30 septembre :** Communiquer pour soutenir l'alliance et coconstruire l'entretien